Dr. Claire Dubois
Verzekeringsgeneeskunde
Hazelarenstraat 7
2020 Antwerpen
03 238 33 10
0497 51 31 71
Claire.lins@skynet.be

Antwerpen, 23 januari 2026

VOORLOPIG DESKUNDIG VERSLAG

Expertise op verzoek van het Fonds voor medische ongevallen in toepassing van art. 17§2 van de Wet van 31 maart 2010

inzake: wijlen mevrouw Brasseur Anna

° 16//01/1949 - † 30/08/2023

Ref FMO 202411N002

Ondergetekenden, dr. Dirk Stockman, geneesheer specialist voor interventionele cardiologie en dr. Claire Dubois, geneesheer-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise hebben de opdracht van het Fonds voor medische ongevallen aanvaard en de expertise uitgevoerd. Zij hebben geen strafrechtelijke en/of tuchtrechtelijke veroordelingen in verband met hun beroepsuitoefening opgelopen, en er zijn ook geen belangenconflicten.

De partijen werden tijdig en aangetekend op de hoogte gebracht van de datum en plaats van de expertisezitting.

De expertisezitting had plaats op 27 november 2025 in de Hazelarenstraat 7, 2020 Antwerpen.

Aanwezig waren:

Mevrouw Helsen Anke	anke.helsen@outlook.com
De heer Helsen Tom	helsen_tom@hotmail.com
Dr. Simon Daenen, raadsarts voor de familie Helsen	simon.m.g.j.daenen@gmail.com
Mr. Melissa Vande Reyde, raadsman van de familie Helsen	melissa@mw-advocatenkantoor.be
Dr. Rossenbacker	tom.rossenbacker@imelda.be
Mr. Vermeiren Rudi en mr. Isabelle Broeckx, raadsman voor de zorgverstrekkers	advocaat@vermeiren-law.be
Dr. Van Melkebeke Marc, raadsarts voor de zorgverstrekkers	info@drmvm.be

1. Persoonlijke gegevens

Beroepsloopbaan

Huisvrouw

Sociale situatie

Gehuwd. Woonde samen met echtgenoot.

Zij nam de zorg op zich voor haar echtgenoot die enkele jaren geleden een herseninfarct had gehad

2. De omstandigheden van de zorgverstrekking

- De medische voorgeschiedenis van de patiënt en zijn medische toestand vóór de ter discussie staande zorgverstrekking beschrijven;

  - bilaterale embolisatie van de vene ovarica
  - stripping van de vena magna links met later redo varicectomie
  - rectocolpexie
  - hallux valgux ingreep
  - episode van idiopathisch non-sustained ventrikeltachycardie, elektrofysiologisch en coronarografisch negatief

- De onderzoeken, technische handelingen, verzorging, behandelingen en interventies die bij de patiënt werden uitgevoerd, beschrijven en in de mate van het mogelijke aangeven door welke zorgverlener en in welke verzorgingsinstelling ze werden verricht;

26/03/2023 Spoedgevallen AZ Sint Maarten Mechelen

Was deze avond met echtgenoot op zijn 80-jarig feest en heeft 4-E consumpties alcohol gedronken. Hierop in hotel rond 23u plots duizelig en wat syncopaal. Nadien wat gevoel van palpitaties. Geen RSP. geen dyspnoe. BD 115/70 en op spoed niet meer syncopaal.
Was met bisoprolol gestopt wegens lagere tensies. Neemt nu enkel Apocard 200rng
…
Technische onderzoeken:
ECG: snelle VKF Labo geruststellend
…
Lixiana 60 mg. 1/d

Bisoprolol 2.5 mg 1/d

Controle bij eigen cardioloog

04/04/2023 raadpleging cardiologie Imelda ziekenhuis

…Patiënt heeft 1 x thuis palpitaties gekend meer dan een uur durend. In de nacht na feestje met matig alcoholgebruik heeft zich een 4 uur durende aanval van irrgguliere snelle hartactie /min) voorgedaan. 0p opname spoedgevallen Sint-Maarten werd VKF met snel (170/min)) ventriculair antwoord vastgesteld.

…

BESPREKING

De palpitaties bij deze u gekende 74-jarigc patiënt zijn recent geobjectiveerd als zijnde VKF met snel ventriculair antwoord. Gezien de klachten zich voordeden onder Flecaïnide en gezien de relatieve intolerantie voor betablokkcr (hypotensie) wordt overgegaan op Amiodarone 200 mg 3 x l per dag eerste week. 2 x 2 per dag tweede week en daarna 1 per dag. dit in afwachting van curatievc ablatie. Patiënts ging akkoord met dit zorgtraject en zal mits uw goedvinden. opgeroepen worden voor informatief gesprek over VKF-ablatie.

Uiteraard wordt behandeling met orale anticoagulatie nadien nog verder gehandhaafd.

03/05/2023 raadpleging cardiologie Imelda ziekenhuis

Patient wordt ons verwezen door collega dr. Janssens met de vraag naar de mogelijkheden van een VICF-ablatie. Er deed zich een gedocumenteerde episode van voorkamerfibrillatie voor onder Flecanïnide. Ze neemt nu Cordarone en Flecainide in. Flecainide kan alvast gestaakt worden. Ze komt voor een VKP-ablatie in aanmerking. Ik legde haar de modaliteiten uit, de te verwachten resultaten en de zeer zeldzame mogelijke complicaties. Lixiana wordt periproceduraal verdergezet alsook Cordarone. Voordien dient nog een CT van het hart genomen te worden. Onze secretaresse zal haar contacteren om verdere praktische schikkingen te treffen.

Informed Consent: De patient/vertegenwoordiger van de patient werd geinformeerd over de behandeling/ingreep/medische procedure, heeft de verstrekte informatie begrepen, mogelijkheid gehad om vragen te stellen, en heeft toegestemd met de behandeling/ingreep/medische procedure.

31/07/2023 opname ablatie cardiologie Imelda ziekenhuis dr. Rossenbacker

Isolatie van de vier pulmonale venen met írrigatiekatheter en gebruik van een navigatiesvsteem (CARTO-mergc).

Graag revaluatie op de raadpleging van Dr T Rossenbacker binnen 3 maanden

15/08/2023 spoedgevallen urgentiegeneeskunde Imelda ziekenhuis

Huidige problematiek
Patiënt presenteert zich op spoed op eigen initiatief wegens thoracale pijn.

Sinds deze nacht last van beperkte adembalingsgebonden thoracale pijn. De pijn is egaal van karakter, qelokaliseerd thv linker hemithorax, niet uitstralend. De pijn duurt enkele uren, en is op spoed al geminderd in intensiteit. Ze heeft deze pijn al vaker gehad op willekeurige momenten, niet inspannings- of houdingsgebonden.
Ze heeft regelmatig last van palpitaties die onregelmatig aanvoelen, ook deze nacht. De palpitaties verdwijnen na een tiental minuten. Ze heeft ook last van lage bloeddrukken, hierdoor regelmatig presyncopaal, voornamelijk bij plots rechtkomen.
Ze is eerder geconstipeerd.
De laatste manden veel stress. Bij stress nood aan mictie.

Verder:
- Geen algemene malaise, geen koorts, geen vermagering, geen nachtzweten - Geen hoesten, geen dyspnee, geen sputa, geen hemoptoë
-Geen abdominale pijnen, geen nausea/braken, geen diarree, geen bloed/slijm bij stoelganq,- Geen dysurie, geen pollakisurie, geen hematurie, geen NSP

…

Verdere technische onderzoeken

ECG
sinusaal regelmatig 79/min, normale as, PR normaal, smal QRS, QTc norrnaai,
geen repolarisatiestoornissen (nieuw RBTB morfologie in V1, gekend in V2)

LABO
CRP 9.7
Hb 13.9
WBC 8.4
nierfunctie nl
trop 13 - contro1e trop 12
leverset nl
ionogram nl
…
Diagnose/besluit
Thoracale pijn
DD pericarditis (Dressier syndroom?)
Status na isolatie pulmonale venen op 31/07 ikv pVKF.

Behandeling
Start Aspegic 3dd 100 mg en pantoprazole 20 mg 1dd
Controle bloedname bij huisarts a 2 dagen, indien geen evolutie inflammatoire parameters stop Aspegic
Patiënte belt morgen naar 015 50 50 95 (consultatie cardiologie) om dringende raadpleging in te plannen

18/08/2023 laboresultaten Somedi

(op voorschrift van de huisarts cfr. controle zoals gevraagd op spoedgevallen op 26/03)

19/08/2023 Contact Wachtpost Heist Telefonisch Consult dr. Gerlo

KLACHTEN:
malaise
voelt zich algemeen niet goed. duizelig.. Gisteren op spoed geweest wegens thoraxpijn . naar huis gestuurd na onderzoek met Aspegic 3/dag. Zou dringende afspraak moeten hebben hij cardio!oog die de ablatie voor VKF heeft gedaan…
BD thuis 98/56 pols 54'
daarna 123/60 en pols 43/
Erg ongerust.
Was erg onbeleefd tegen onthaalbediende

KLINISCHE WAARNEMINGEN:
Telefonisch contact met patiënt geen fysiek klinische onderzoek

DIAGNOSE:
duizeligheid
Contact met Labo Somedi- staal van 18.08.203 toont Sed . 52e, CRP 84. Normale hemato.
lnflammatie??
Rusten Aspegic verder
ev Terug naar Spoed als het niet gaat
vermoeden hyperventilatie ....)

21/08/2023 contactverslag dr. Hugo De Greef

thoracale pijn

22/08/2023 telefonisch cobtact met dr. Rossenbacker

27 tot 30/08/2023 opname dienst cardiologie Imelda ziekenhuis

Via spoedgevallen

Opmerking tijdens de zitting:

Patiënte werd met ambulance binnengebracht na val in keuken. Ze had veel last van stress de weken voorafgaand aan 27/08/2023

Huidige problematiek

Spoedpresentatie: Presentatie op eigen initiatief.
Mevrouw komt naar de spoedgevallen omdat ze heel veel stress heeft. Ze zorgt al 5 jaar voor haar man die een beroerte gehad heeft. Nu recent ook ruzie met haar dochter.
Mevrouw heeft pijn op de borst, niet uitstralend, niet ademhalings- of bewegingsgebonden. Ze geeft zelf aan dat dit van de stress komt.
Tevens rillingen die eindigen in hevige schokken, geen bewustzijnsverlies. Koud, maar geen koorts. Beterschap met xanax.
Systeemanamnese negatief.
…
Conclusie spoed (cardio:)Thoracale pijn en inflammatoir labo dd perimyocarditis
Presentatie op eigen initiatief wegens aanhoudende, toenemende stekende pijn thoracaal. Eveneens hoofdpijn, algemene malaise.
ECG toont sinusritme met lichte ST-optrekking in I en AVI, negatieve T in III. Biochemie fors inflammatoir met CRP van 130 met neutrofilaire linksverschuiving. Troponines verhoogd tot 6Ong/L, vorige week nog volledig normaal, bij herhaling 100 ng/L. Radiografie thorax zonder verdichtingen.

27/08 Neurologisch consult:

We zagen uw patiente in consult omwille van een wisselend hemibeeld. Een functionele origine (familiaal duidelijk reden hiervoor) is meest
waarschijnlijk, maar niet zeker. Echter op heden weinig therapeutische
implicaties gezien Lixiana. Bij progressie graag hercontactname voor een herevaluatie
…

BESLUIT:

Uw 74-jar1ge patientef BRASSEUR Anna, werd opgenomen voor de afdeling Cardiologie van 27-08-2023 tot en met 30-08-2023, We weerhouden:
I. S. Mitis endocarditis met overwhelming septische embolisatie

Presentatie op eigen initiatief wegens aanhoudende, toenemende stekende pijn thoracaal. Eveneens hoofdpijn en algemene malaise. ECG toont sinusritme met aspecifieke lichte ST-afwijkingen. Initiële biochemie fors inflammatoir met CRP van 130 mg/dL met neutrofilaire linksverschuiving en matig verhoogde troponines tot 60 ng/L. CT schedel initieel zonder bijzonderheden.
Kort na opname progressieve, acute neurologische achteruitgang met snel ontwikkelen van comateuze toestand.
Differentieel diagnostisch werd initieel gedacht aan meningitis waarvoor start breed spectrum antibiotische en anti-virale therapie. Echter op nieuwe CT schedel ontstaan van acute ischemie in multi vessel gebieden zonder bloedvatocclusies/thrombi.
In overleg met dienst Neurologie geen therapeutioche opties meer. TTE toont nieuw verminderde ejectiefractie tot 30 % met uitgebreide akinesie apicaal zonder duidelijke thrombi of toegevoegde vegitaties. Hemoculturen positiveerden voor S. Mitis en klinisch ontwikkelen van janeway lesions,
Aldus sterk vermoeden van S. Mitis endocarditis van natieve klep met uitgebreide perifere embolisatie en secundaire cerebrale en cardiale ischemie. Onduidelijk of er relatie is met recente PVI cfr punt 2. Verderzetting van Ceftriaxone naast supportieve zorgen, gezien neurologische status geen TEE of cardio PET-CT mogelijk.
Snel verdere deterioratie met op 29-08 respiratoir arrest met noodzaak tot intubatie en transfer naar intensieve zorgen. Aldaar beeld van multi orgaan falen waarvoor agressieve rescucitatie en uitbreiding antibioticabeleid, desondanks verdere achteruitgang. Nieuwe CT schedel toonde eveneens nieuwe diffuus verspreide ischemie in beide cerebraie hemisferen evenals cerebellair. Gezien aldus zeer nefaste prognose zowel cardiaal als neurologisch, werd in overleg met familie overgegaan op comfortbeleid. U patiente kwam te overlijden in bijzijn van familie op 30-08-2023. …

Bespreking tijdens de zitting

- ✓ Er wordt door dr. Dirk Stockman bijkomende uitleg gevraagd aan dr. Rossenbacker inzake de gevolgde procedure. Hierbij was er een juiste indicatiestelling. De ingreep werd lege artis uitgevoerd, waarbij alle voorzorgen werden genomen voor een veilige uitvoering ervan.

- ✓ Dr. Daenen stelt dat pathologie die op chronologische basis optreedt binnen de 4 weken na een ingreep beschouwd wordt als een gevolg van die ingreep. De deskundigen antwoorden dat hier inderdaad de pathologie vanaf 15 augustus chronologisch gelinkt is maar dat er geen causaal verband is tussen de pathologie opgetreden vanaf 15 augustus 2023 en de ingreep (ablatie) op 31/07/2023

- ✓ Dr. Stockman legt uit dat gezien de delay tussen 31/07 en 15/08, datum van eerste (spoed)raadpleging, en gezien de symptomatologie, complicaties zoals infectie, endo- of pericarditis of optreden atrio-oesofagiale fistel als complicatie van de ablatie moeten uitgesloten worden voor de ziektetoestand vanaf 15 augustus.

- ✓ De familie haalt aan dat mevrouw Brasseur zich de weken voordien ook niet goed voelde. Daarop antwoorden de deskundigen dat, indien een complicatie als gevolg van de ablatie zich zou voorgedaan hebben, de klinische toestand van de patiënte op 15/08 helemaal anders zou geweest zijn. De klachten die patiënte volgens de familie vertoonde hebben geen aanleiding gegeven tot consulteren

- ✓ De raadsman van de familie Helsen stelt dat de familie van mening is dat er, na 15/08, gemiste kansen geweest zijn om het overlijden te vermijden. Hierbij wijzen ze meer specifiek naar het feit dat:

    - De spoedarts op 15/08 zelf voor een afspraak bij de cardioloog had moeten zorgen. De deskundigen stellen dat dit geen opdracht is van de spoedarts, bovendien heeft de spoedarts niet de mogelijkheid daartoe

    - Wegens vakantieperiode de huisarts niet bereikbaar was

    - Dr. Rossenbacker alleen telefonisch kon geconsulteerd worden. Over dit telefoongesprek lopen de strandpunten uiteen. Dr. Rossenbacker stelt zich er niet veel van te herinneren maar heeft volgens hem gezegd dat hij patiënte moest zien. Volgens de familie werd door hem gezegd dat dringende raadpleging niet nodig was, dat geplande raadpleging voor november kon blijven staan en dat een hartinfarct gezien de goede coronarografie niet waarschijnlijk was.

    - De familie erkent dat het voor de patiënte een zeer stressvolle periode was

- ✓ De heer Helsen vraagt veel uitleg over het ontstaan van de sepsis als gevolg van een huidbacterie

- ✓ De deskundigen herhalen dat de patiënte is overleden aan een sepsis waarvan de etiologie ongekend is. Er gebeurde geen autopsie, het vermoeden van endocarditis is niet onderbouwd en niet te verwachten bij normale hartkleppen. Er is geen enkele reden waarom cardiale pathologie als vermoedelijke oorzaak zou weerhouden worden

- ✓ De familie vraagt zich af wat de zitting heeft bijgebracht en welke bijkomende informatie ze heeft opgeleverd

- De omstandigheden met betrekking tot de zorgverstrekking en de klachten van de patiënt verduidelijken

Namens wijlen mevrouw Brasseur Anna werd een adviesaanvraag aan het Fonds gericht betreffende schade die zij meent te hebben geleden ten gevolge van medische behandeling op 15, 18 en 22/08/2023.

- Advies geven over het naleven van de regels van de kunst door na te gaan of de zorgverlener in het kader van de verzorging van de patiënt (geïnformeerde toestemming, diagnose, indicatie, behandeling, postoperatieve follow-up ...) heeft gehandeld zoals een normaal vooruitziend en zorgvuldig zorgverlener, in dezelfde omstandigheden en rekening houdende met de stand van de wetenschap op het ogenblik van de feiten, zou hebben gehandeld;

Wat betreft de ingreep dd. 321/07/2023 nl. ablatie uitgevoerd door dr. Rossenbacker

De indicatie werd terecht gesteld

Informed consent: De ingreep werd met patiënte besproken (zie raadpleging dd. 03/05/2023) en IC wordt niet betwist

De ingreep zelf gebeurde lege artis

De nabehandelingen gebeurden zoals een normaal vooruitziend en zorgvuldig zorgverlener, in dezelfde omstandigheden en rekening houdende met de stand van de wetenschap op het ogenblik van de feiten, zou hebben gehandeld

Wat betreft de medische problematiek gerapporteerd vanaf 15/08/2023:

Deze pathologie kan niet gelinkt worden aan een zorgverstrekking en meer bepaald aan de ablatie dd. 31/07/2023.

Ze is het gevolg van de medische toestand van de patiënt en is niet het gevolg van onzorgvuldig handelen van dr. Rossenbacker.

Patiënte overleed aan een sepsis waarvan de etiologie niet met zekerheid kon worden vastgesteld.

3. **De analyse van de schade**

- Oordelen of de schade het gevolg is van een zorgverstrekking

De schade is niet het gevolg van een zorgverstrekking of van het ontbreken ervan maar wel van de medische toestand van de patiënt

- Oordelen of de opgetreden schade in voorkomend geval het gevolg is van een voorzienbare complicatie die inherent is aan de toegepaste behandeling en in casu aangeven hoe vaak deze complicatie optreedt, met medische literatuur ter staving en rekening houdende met de gezondheidstoestand van de patiënt en zijn objectief voorspelbare evolutie;

Niet van toepassing gezien het geen complicatie betreft

- ▪ Verduidelijken, met medische literatuur ter staving, of de evolutie en de schadelijke gevolgen die de patiënt heeft doorgemaakt, normaal verwacht kunnen worden bij dit type complicatie, rekening houdend met de gezondheidstoestand van de patiënt en zijn objectief voorspelbare evolutie

Niet van toepassing gezien het geen complicatie betreft

- Preciseren of in casu alternatieve behandelingsmethoden konden worden toegepast
    - die met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de patiënt niet zouden hebben blootgesteld aan een identiek risico op dezelfde complicatie of een complicatie met een vergelijkbare of grotere ernst;
    - en die dezelfde of een vergelijkbare succesratio zouden hebben gehad als de in casu toegepaste behandelingsmethode;

Niet van toepassing

4. <u>Evaluatie van de schade</u>

De schadeverwekkende gevolgen evalueren die voortvloeien uit een eventuele tekortkoming ten aanzien van de regels van de kunst en/of een of meerdere mogelijke complicaties, los van de sequelen die verband houden met de voorafbestaande toestand en de objectief voorspelbare evolutie van de patiënt, die hoe dan ook zouden zijn opgetreden zonder het schadeverwekkende feit;

- **Voorafbestaande toestand**

  - De voorafbestaande toestand van de patiënt beschrijven;

    Niet van toepassing. Het betreft hier geen tekortkoming ten aanzien van de regels van de kunst noch een of meerdere mogelijke complicaties

- **Objectief voorzienbare evolutie**

  - Advies geven over de voorzienbare gevolgen van de zorgverstrekking indien het schadeverwekkende feit zich niet had voorgedaan, rekening houdend met de voorafbestaande toestand van de patiënt. Zich in het bijzonder uitspreken over:

    - Het genezingsproces
    - De hospitalisatieduur
    - De graad en de periodes van de arbeidsongeschiktheid
    - De graad en de periodes van de tijdelijke persoonlijke en huishoudelijke ongeschiktheid
    - De blijvende ongeschiktheden
    - De medische behandelingen

    Niet van toepassing gezien het geen schadeverwekkend feit betreft

  - Verduidelijken of het overlijden het gevolg is van de objectief voorzienbare evolutie van de initiële aandoening

    Het overlijden is het gevolg van de medische toestand van de patiënte die echter geen verband houdt met de ingreep dd. 31/07/2023

- **Tijdelijke schade tot de datum van overlijden**

o <u>Tijdelijke ongeschiktheid</u>

- De duur en de graad van de eventuele tijdelijke persoonlijke, huishoudelijke en economisch ongeschiktheid evalueren;

Persoonlijke ongeschiktheid:

gelinkt aan de ingreep dd. 31/07/2023

100 % op 31/07/2023

30 % van 01 tot 06/08/2023

10 % van 07 tot 10/08/2023

0 % van 11 tot 14/08/2023

gelinkt aan de medische toestand van patiënte

80 % op 15/08/2023

30 % van 16 tot 26/08/2023

100 % van 27/ 08 tot overlijden op 30/08/2023

Huishoudelijke ongeschiktheid

Geen buiten de opname

Economische ongeschiktheid

Niet van toepassing

o Tijdelijke specifieke schade

- De duur en de ernst van het eventuele quantum doloris op een schaal van 0 tot 7 beschrijven en evalueren indien dit niet is opgenomen in de tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid;

Inbegrepen in persoonlijke ongeschiktheid

- De duur en de ernst van de eventuele esthetische schade op een schaal van 0 tot 7 beschrijven en evalueren (indien nodig aangetoond aan de hand van foto's);

Geen

- Aangeven of de toestand van de patiënt al dan niet de hulp van een gekwalificeerde derde persoon heeft vereist en in voorkomend geval de aard van de hulp en de omvang van het uurrooster vermelden;

Geen

- Oordelen of de toerekenbare schadelijke gevolgen eventueel een weerslag hebben gehad op het seksleven van de patiënt (pretium voluptatis) en in voorkomend geval de ernst ervan evalueren

Geen

- Aangeven of de toestand van de patiënt medische of paramedische verzorging of medische behandelingen heeft vereist en deze in voorkomend geval beschrijven;

Geen buiten de opname

-Aangeven of de toestand van de patiënt een prothese, een orthese of andere materiële hulpmiddelen heeft vereist;

Geen

- Nagaan of de patiënt tot de datum van zijn overlijden nog andere schade heeft geleden die kan worden toegeschreven aan een eventuele tekortkoming ten aanzien van de regels van de kunst en/of een of meerdere mogelijke complicaties;

Geen